



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
INSTALASI RAWAT INAP
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3, Mondoroko, Singosari - Malang
Telp. 0341 - 458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



**PROGRAM KERJA UNIT/INSTALASI RAWAT INAP
RS PRIMA HUSADA MALANG TAHUN 2026**

**BAB I .
PENDAHULUAN**

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medis yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit harus melakukan upaya peningkatan mutu dan pelayanan medic baik melalui akreditasi, sertifikasi, ataupun proses peningkatan mutu lainnya. Secara komprehensif dan integratif yang menyangkut struktur, proses secara objektif. Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan memberikan dua jenis pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit rawat inap.

Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Agar pelayanan yang baik tersebut dapat tercapai dan bertahan lama, maka Rumah Sakit harus membangun sistem pelayanan yang baik dan tidak bergantung pada salah satu unit atau dokter tertentu saja. Pelayanan kesehatan yang diberikan harus diupayakan agar bersifat komprehensif dengan melibatkan tim dokter dari berbagai bidang spesialisasi, ditunjang oleh sarana diagnostik yang baik serta unit pendukungnya.

Mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu didukung oleh sumber daya yang dimiliki, meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan medis. Dalam perkembangannya rumah sakit telah berubah menjadi suatu institusi yang sangat kompleks sehingga memerlukan suatu manajemen yang baik. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan keseluruhan upaya dan kegiatan Program kerja merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit khususnya di Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Melalui program kerja ini diharapkan rencana kerja di Instalasi Rawat Inap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Dalam rencana kerja tahun 2026 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan

Meningkatnya pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat menuntut perubahan pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih ramah dan bermutu. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan maka fungsi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan rumah sakit secara bertahap perlu ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, pelayanan kesehatan merupakan ranah yang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi telah merubah cara hidup orang banyak dalam menentukan pilihan yang nantinya akan mengakibatkan persaingan. Hal ini membuat banyak organisasi termasuk pelayanan kesehatan terus-menerus melakukan peningkatan dalam kualitas dan melakukan inovasi dalam pelayanan.

Kunjungan pasien rawat inap RS Prima Husada setiap bulan selama tahun 2025 masih fluktuatif, namun relatif meningkat. Terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berobat, ruang rawat inap tetap harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan lagi jumlah kunjungan. Untuk itu diperlukan program yang sistematis untuk mencapai target yang diharapkan.



Ruang lingkup pelayanan meliputi dukungan fungsi organ-organ vital seperti pernafasan, kardiovaskuler, susunan saraf pusat, ginjal dan lain-lain, baik pada pasien dewasa ataupun anak. Rumah Sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan mempunyai fungsi rujukan harus dapat memberikan pelayanan Rawat Inap yang profesional dan berkualitas.

Agar semua hal tersebut diatas dapat terlaksana, maka perlu disusun suatu Program Kerja Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Prima Husada Malang Tahun 2026 yang mencakup program mutu Rawat Inap, program keselamatan Rawat Inap serta program pengelolaan peralatan Rawat Inap.

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 200.50/DPM/I-KEP/DIR/II/2022 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;
12. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada

1.2. Maksud dan Tujuan

Terselenggaranya pelayanan rumah sakit secara optimal sesuai dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Prima Husada Malang

1. Terselenggaranya pelayanan Instalasi Rawat Inap yang bermutu
2. Tersedianya SDM yang profesional dan berkualitas
3. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan medis yang memadai
4. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk karyawan, pasien dan pengunjung rumah sakit.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Prima Husada Malang agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis.



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2. Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberi pelayanan yang bermutu dengan berorientasi pada keselamatan dilandasi dengan hati yang penuh kasih pada sesama.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.3. Motto

Sahabat Menuju Sehat”

2.4. 7 Nilai Budi Utama

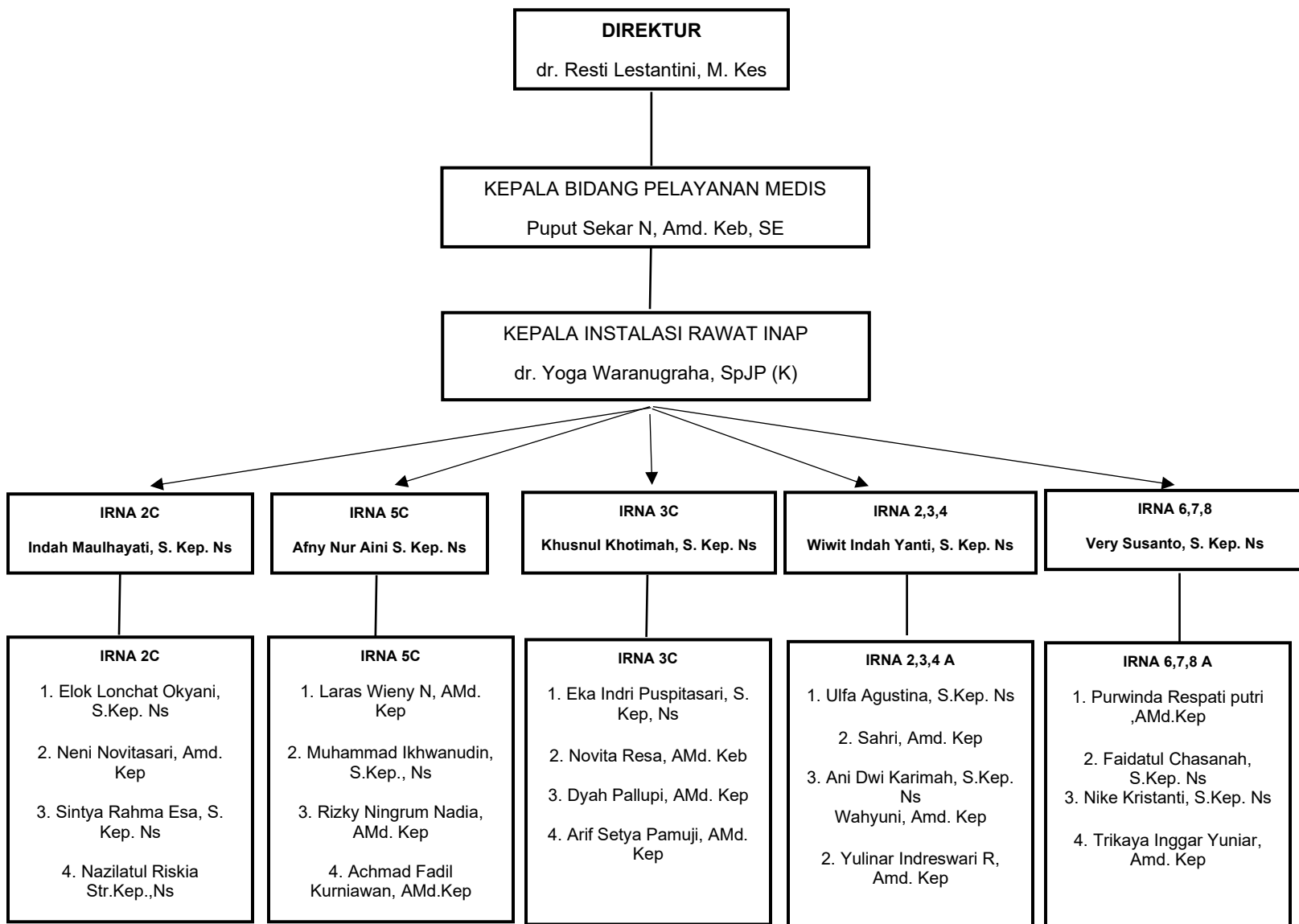
Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli



2.5. SOTK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT RAWAT INAP





2.6. Permasalahan kinerja tahun 2025 (ringkasan/program yang belum berhasil/ kasus-kasus yang terjadi/masalah-masalah)

BAB III.
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
3.1.1	SDM	
1	Perekrutan SDM sesuai dengan kebutuhan	1. Perekrutan staf perawat oleh SDM dan kebutuhan perawat pelaksana untuk kebutuhan tahun 2025 yaitu sebanyak - orang perawat
2	Orientasi khusus	1. Persiapan orientasi 2. Pemberian teori materi orientasi Pedoman/panduan , SPO. Alur, Regulasi , pre post tes, 3. Pembimbingan Praktek/pendampingan praktek : a. Asisten pemasangan INFUS, b. Asiten pemasangan NGT, c. Asiten pemasangan CATETER d. Asisten Rawat Luka 4. Evaluasi kinerja orientasi
3	Pendidikan dan Pelatihan (Seminar dan Workshop)	A. Internal 1. Diklat : MFK-K3 2. Diklat Mutu 3. Diklat PPI 4. Diklat PKRS 5. Diklat KE 6. Ponex 7. BHD B. Eksternal 1. Pelatihan manajemen bangsal untuk 2. karu dan segala macam update ilmu-ilmu terbaru 2. BTCLS
4	Penilaian Kinerja	1. Observasi harian staf 2. Supervisi dengan ceklist
3.1.2	PENGEMBANGAN PELAYANAN IRNA	1. Penyediaan fasilitas toiletris untuk pasien ruang VIP dan VVIP 2. Pelatihan perawatan luka 3. Pelatihan manajemen bangsal 4. Pelayanan ERM rawat inap full tanpa kertas 5. Alur yang mempercepat peningkatan kunjungan pasien 6. Taman bermain untuk ruangan anak
3.1.3	PELAYANAN IRNA	1. Monitoring Pasien 24 jam 2. Resusitasi pasien 3. Perawatan pasien dengan NGT 4. Perawatan pasien dengan CATETER 5. Perawatan pasien ISOLASI 6. Kriteria keluar masuk ICU 7. Transfer Pasien 8. Pemeriksaan ECG
3.1.4	MFK	
1	Pemeliharaan aldok, alkes, elektronik bulanan	1. Memantau pemeliharaan alat oleh IPSRS: a. AC b. Komputer c. Syring Pump d. Infus Pump e. Ventilator f. Monitor g. Echo h. ECG



		i. Nebulizer j. Suction
2	Kalibrasi	2. Kalibrasi alat : a. Syring Pump b. Infus Pump c. Ventilator d. Monitor e. Echo f. ECG g. Nebulizer h. Suction
3	Pemeliharaan harian	3. Melakukan pemeliharaan-kebersihan setiap hari oleh unit, ATEM dan IPSRS secara berkala : a. AC b. Komputer c. Syring Pump d. Infus Pump e. Ventilator f. Monitor g. Echo h. ECG i. Nebulizer j. Suction
4	Penambahan Alat	4. Belum ada rencana penambahan alat di IRNA 2C VIP untuk tahun 2026
3.1.5	K3	1. Pemantauan dan laporan MCU 2. Pemantauan dan laporan Immunisasi 3. Pemantauan dan laporan PMT 4. Pemantauan dan laporan Konseling 5. Pemantauan mangkir kerja 6. Pemantauan dan laporan Pemantauan dan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
3.1.6	MUTU	1. Kepatuhan identifikasi pasien 2. Kepatuhan waktu visite dokter 3. Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) 4. Prosentas pulang atas permintaan sendiri 5. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh 6. Angka kelengkapan penulisan dalam CPPT 7. Angka rujukan horizontal FKRTL - Angka kelengkapan SBAR di CPPT
3.1.7	PPI	1. Angka Infeksi aliran darah perifer (phlebitis) 2. Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas 3. Angka kepatuhan kebersihan tangan 4. Angka decubitus 5. Angka infeksi pneumonia pada penggunaan ventilator (VAP) 6. Angka infeksi daerah operasi (IDO) 7. Angka infeksi saluran kencing (ISK) 8. Angka infeksi aliran darah primer (IADP) 9. Kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius di unit pelayanan 10. Angka kepatuhan kebersihan tangan unit farmasi
3.1.8	PKRS	1. Edukasi Individu (total pasien 100%) 2. Edukasi Kelompok (2x/mg) 3. Edukasi Massa/IG/Radio (2x/mg)
3.1.9	MONEV	
1	Rapat (Evaluasi)	1. Rapat Unit 1x/bln 2. Rapat Koordinasi/manajemen/antar unit (rapat bulanan) 3. Rapat insidental : IKP/sesuatu urgen 4. Rapat Kerja tahunan : PT.DPM
2	Supervisi (monitoring)	1. Pemantauan harian 2. Pemantauan mingguan 3. Pemantauan bulanan 4. Breafing/HO



3.1.10	REKREASI IRNA	
1	Rekreasi atau gathering	Rekreasi bertahap di luar RS

3.2. Sasaran

(LANDSCAPE)							
NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	SDM Rekrutmen karyawan	Memenuhi kebutuhan karyawan sesuai dengan standart	Perawat pelaksana	Rekrutmen	-	Jumlah rekrutmen karyawan baru sesuai dengan standart SDM	
2	Pengembangan dan pelatihan IRNA 2C (External dan Internal)	1. Update ilmu mengenai pelayanan di IRNA sebagai pencapaian standart SDM a. Pelatihan manajemen bangsal (external) b. Pelatihan yang diadakan di rumah sakit (internal) 2. Meningkatkan pelayanan di irna dan jumlah pasien bisa stabil dan meningkat	1. Kepala ruang dan perawat ruang 2. Pasien dan keluarga	1. Diklat 2. Pelayanan	1. 1 kepala ruang dan 6 perawat 2. 0%	1. Jumlah kepala ruang yg mengikuti manajemen bangsal 2. Jumlah perawat yg mengikuti pelatihan interna 3. Kritik dan saran terkait pelayanan rawat inap	
3	PELAYANAN IRNA 1. Monitoring Pasien 24 jam 2. Resusitasi pasien 3. Perawatan pasien dengan NGT 4. Perawatan pasien dengan CATETER 5. Perawatan pasien ISOLASI 6. Kriteria keluar masuk ICU 7. Transfer Pasien 8. Pemeriksaan ECG	Observasi, perawatan pasien resusitasi, pasang/ lepas NGT, CATETER, perawatan pasien isolasi, kriteria keluar masuk icu, transfer pasien dan melakukan Ecg bila perlu	Pasien	Pelayanan	Semua pasien irna 2c	Pasien irna monitoring 24 jam Kritik dan saran pelayanan	
4	MFK : Fasilitas: 1. Pemeliharaan alat 2. Kalibrasi alat Penggantian/pe nambahan	Memperlancar pelayanan sehingga tidak ada hambatan	Semua alat medis dan non medis yang ada di unit	Alat Medis/Non Medis	1. 100% 2. 100% 3. 0%	1. Alat bisa digunakan dengan baik dan benar 2. Akurasi alat 3. Alat tidak bisa difungsikan lagi	
5	K3 : 1. Keselamatan pasien 2. Keselamatan kerja	1. Tidak ada resiko pasien dan menjaga keselamatan pasien 2. Menjaga keselamatan SDM diseluruh unit	1. Pasien 2. Karu dan Perawat pelaksana	1. pasien 2. SDM Irna	1. 100% 2. 0%	1. Tidak ada insiden Keselamatan pasien yang mengakibatkan cedera 2. Karyawan yang tidak patuh penggunaan APD (alat pelindung diri) dan tidak melakukan semua prosedur sesuai SPO	



6	MUTU : 1. Kepatuhan identifikasi pasien 2. Angka kepatuhan waktu visite dokter spesialis 3. Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap 4. Kepatuhan terhadap alur klinis 5. Prosentase pulang atas permintaan sendiri 6. Angka Rujukan Horizontal (FRTKL) 7. Angka Walk Through Audit 8. Angka kelengkapan penulisan perawat dalam CPPT 9. Angka kelengkapan SBAR dalam CPPT	Menjaga keselamatan pasien	Karu perawat pelaksana dan pasien keluarga	Mutu Ima	1. 100% 2. 85% 3. 100% 4. 100% 5. 0% 6. 0% 7. 0% 8. 100% 9. 100%	1. Melakukan sosialisasi SKP tentang identifikasi pasien 2. Melakuakan supervisi karu terhadap kepatuhan 3. Koordinasi kepada DPJP terkait kepatuhan waktu visite 4. Melakukan kroscek jam visite di CPPT 5. Melakukan supervise kepada anggota unit dalam melakukan asesmen dan skrinning resiko jatuh 6. Melakukan supervise kepatuhan alur klinis 7. Melakukan komunikasi ulang pada pasien yang rencana pulang atas permintaan sendiri 8. Supervisi tiap bulan terhadap kejadian pasien pulang atas permintaan sendiri 9. Supervise terhadap angka rujukan horizontal 10. Koordinasi dengan tim Asuransi Center terhadap adanya WTA 11. Sosialisasi kelengkapan penulisan CPPT terhadap staff Rawat Inap 12. Sosialisasi kelengkapan penulisan SBAR dalam CPPT terhadap staff Rawat Inap	
7	Refreshing karyawan	Refreshing SDM IRNA	SDM irna	SDM irna	100%	Spikologis SDM irna 2C stabil	



3.3. Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Perekrutan SDM sesuai dengan kebutuhan	Melakukan rekrutmen melalui bagian SDM	1. Internal (referensi karyawan, pengumuman dan pengajuan pekerjaan) 2. Eksternal (Media iklan, Brosur online)	Media social (WA, IG, Website, Facebook, Goegle)	Bulan Juni dan Desember	1. Tes tulis Tes Wawancara 3. Dokumentasi (foto)	
2	1. Mengikuti pelatihan manajemen bangsal untuk 5 orang kepala ruang. 2. Mengikuti seminar internal maupun eksternal mengenai rawat inap dan segala macam update ilmu-ilmu terbaru 3. Mengadakan seminar internal tentang rawat inap Rumah Sakit Prima Husada a. Membentuk tim panitia seminar b. Menentukan tema seminar c. Membuat proposal d. Sertifikat seminar e. Sosialisasi	Koordinasi dengan SDM, Even Organizer dan Tim	Pelatihan eksternal Diskuasi	Offline/online	menyesuaikan	Laporan hasil pelaksanaan dan kegiatan	
3	1. Melakukan pemeliharaan alat terkait pelayanan di rawat inap : a. ECG b. Nebulizer c. Tensimeter d. Thermomete e. Oximetry f. Bagging h. Set Rawat Luka i. Monitor ECG 2. Rencana penambahan alat	Koordinasi dengan IPSRS dan PJ Alat Medis di rawat inap dan pengajuan pengadaan	1. Kalibrasi/ pengecekan alat 2. Pengajuan alat	1. IPSRS koordinasi dengan vendor terkait 2. SIMRS	1. 1 bulan sekali/ 1 tahun sekali 2. menyesuaikan kebutuhan	1. Kartu kontrol alat/ sertifikasi kalibrasi 2. Serah terima (Bukti FS dari sekretariat) atau form pengajuan alat	
4	MTK 1. Keselamatan pasien 2. keselamatan kerja	1. Koordinasi dengan PJ K3RS untuk pengisian/ pelayanan unit secara benar dan teratur 2. Koordinasi dengan PJ K3RS untuk pengisian/ pelayanan unit secara benar dan teratur	diskusi	SIMRS/GOEGLE	Menyesuaikan	Laporan kegiatan	



5	MUTU 1. Kepatuhan identifikasi pasien 2. Angka kepatuhan waktu visite dokter spesialis 3. Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap 4. Kepatuhan terhadap alur klinis 5. Prosentase pulang atas permintaan sendiri 6. Angka Rujukan Horizontal (FRTKL) 7. Angka Walk Through Audit 8. Angka kelengkapan penulisan perawat dalam CPPT 9. Angka kelengkapan SBAR dalam CPPT	Koordinasi dengan PJ Mutu untuk pengisian mutu unit secara benar dan teratur, SPO	diskusi	SIMRS/GOEGL E	Setiap hari	simrs	
6	PPI 1. Angka Infeksi aliran darah perifer (phlebitis) 2. Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas 3. Angka kepatuhan kebersihan tangan 4. Angka decubitus 5. Angka infeksi pneumonia pada penggunaan ventilator (VAP) 6. Angka infeksi daerah operasi (IDO) 7. Angka infeksi saluran kencing (ISK) 8. Angka infeksi aliran darah primer (IADP) 9. Kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius di unit pelayanan 10. Angka kepatuhan kebersihan tangan unit farmasi						
7	PKRS 1. Edukasi Individu (total pasien 100%) 2. Edukasi kelompok (2x/mg) 3. Edukasi massa/radio/IG (2x/mg)	Koordinasi dengan PJ PKRS dan karu unit	CERAMAH	Leaflet/ link PKRS	1x dalam 1 minggu	Laporan kegiatan	
8	MONEV 1. Rapat (evaluasi) 2. Supervisi (monitoring)	Rapat dan pelaporan	ceramah	Computer/laptop	1x dalam 1 bulan	Laporan kegiatan	



9	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap 6 bulan dengan cara OPPE	Penilaian karu	Goegle drive (link)	Evaluasi setiap 6 bulan sekali (semester)	Laporan hasil pelaksanaan	
10	Catatan dan pelaporan	Laporan kegiatan	ceramah	Computer/laptop	1.Setiap hari 2. 1x 1 mingg 3. 1x 1 bulan 4. 1x 3 bulan 5. 1x 6 bulan 6. 1x 1 tahun		
11	Outbond karyawan	Koordinasi dengan bagian SDM, EO dan Tim	diskusi	Offline	menyesuaikan	Laporan kegiatan	

a. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

N O	KEGIATAN	SASARA N	BULANTAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET			
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2. Perekrutan SDM sesuai dengan kebutuhan 3. Mengikuti pelatihan Manajemen bangsal 4. Mengikuti seminar eksternal mengenai rawat inap 5. Evaluasi Kinerja	Perawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	Unit irna	SD M, KARU	Rumah sakit Pribadi	Rp. 70.000,- Hanya untuk pelatihan internal 6 bulan sekali, (7 orang, perawat dan bidan) dengan anggaran @ Rp. 10.000,- Untuk pelatihan eksternal bisa dengan biaya pribadi/ dari RS (dengan kesepakatan terlebih dahulu)		
			-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-						
			-	-	-	-	V	-	V	-	V	V	-	-	-						
			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V						
2	1.Penambahan a. biaya baju dan sandal pasien VIP/VVIP	- perawat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Unit irna	karu	Rumah saki		



	b.Paket mandi 2. Outbond Karyawan																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



3.5. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RSPH Malang yang telah disetujui oleh PT.DPM

No	Bahan	Rata /BI	Kebutuhan 1 Th		Harga Satuan	Total Rp
1.	Handwash Yuri/ 3,7 Liter	17	204	Jurigen	129.000	26.316.000
2.	Alkohol 70%	15	132	Botol	32.694	4.315.608
3.	Kassa Hidrofil	5	60	Rol	199.525	11.971.500
4.	Leukoplast	8	96	Rol	41.012	3.937.152
5.	Accu Check Stick Guide	8	64	Bok	385.000	24.640.000
6.	Accu Check Safe T-Pro Uno	6	72	Bok	145.000	10.440.000
7.	Ky-Gel	5	60	Botol	13.457	807.420
8.	Hypafik	15	180	Bok	54.340	9.781.200
9.	Kerstas Ecg	7	84	Rol	67.500	5.670.000
10.	Elastomul	54	648	Rol	24.759	16.043.832
11.	Saftey Bok	48	186	Bok	20.000	44.640.000
12.	Hanrub	8	96	Jirigen	800.000	76.800.000
Total						221.222.140

Contoh kebutuhan biaya pengembangan SDM Ruang Rawat Inap RSPH Malang Tahun 2026

NO	Kegiatan /rincian kegiatan	Internal eksternal	Jumlah (satuan)	HARGA SATUAN	TOTAL Rp
1	Pelatihan tentang pelayanan rawat inap Manajemen Bangsal (Karu)	Internal	Rp. 10000/ orang	Rp. 5.500.000/ orang	Rp. 1.750.000 Rp. 11.000.000
2	Outbond karyawan	2 thn sekali (7 orang perawat)	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 7.000.000
3	Biaya kalibrasi alat	1 th sekali	RP. 50.000.000	RP. 50.000.000	RP. 50.000.000



BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI

4.1 EVALUASI JADWAL KEGIATAN

Supervisi dilakukan oleh kepala ruangan setiap hari

Supervise PIC PPI, Mutu, MFK-K3, PIC Logistik dilakukan setiap hari

Jadwal kegiatan tersebut akan dimonitoring dan dievaluasi setiap satu bulan sekali, sehingga bila dari evaluasi diketahui ada pergeseran/ penyimpangan jadwal dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara keseluruhan. Evaluasi skedul (jadwal) kegiatan tersebut dilakukan oleh kepala instalasi

4.2 PELAPORAN EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja 2 bulan atau bensmarking, yang ada di unit adalah :

- a. Rapat unit dilakukan rutin 1 bulan 1 kali
- b. Rapat isidentil dilakukan jika ada IKP
- c. Rapat koordinasi lintas program/ unit dilakukan 1 minggu 1 kali yg dihadiri oleh Direktur
- d. Breefing/ operan jaga (pagi,siang, malam)

Evaluasi pelaksanaan program kerja secara keseluruhan dilakukan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan atau dengan cara mencocokkan waktu pelaksanaan dengan jadwal pelaksanaan program. Evaluasi pelaksanaan program kerja dilaksanakan setiap satu bulan sekali.



BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

5.1 PENCATATAN KEGIATAN

Pencatatan kegiatan di dalam program dilakukan dengan cara hasil kerja setiap hari. Laporan program dibuat dengan memasukkan unsur-unsur terkait rencana kerja atau dengan cara menulis hasil laporan, pemenuhan kualifikasi SDM, pemeliharaan alat, kalibrasi alat.

Semua sudah ada dipencatatan berupa :

- a. Lembar supervisi
- b. Pencatatan pada SIM
- c. Buku edukasi kelompok
- d. Buku catatan karu

5.2 PELAPORAN KEGIATAN

Laporan kegiatan yang ada di unit IRNA adalah :

- a. Laporan Bulanan
- b. Laporan Tahunan

Laporan dibuat setiap satu bulan sekali, dan diserahkan kepada Kabid Pelayanan dan Direktur RS Prima Husada. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara keseluruhan dilakukan terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan program kerja dilaksanakan setiap satu tahun sekali.



BAB VI PENUTUP

Demikian program kerja ini dibuat, besar harapan kami agar program kerja Instalasi Rawat Inap 2024 dapat berjalan sesuai jadwal dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap pasien

Penyusun
Kepala Instalasi Rawat Inap



dr. Yoga Waranugraha, SpJP(K)

Diverifikasi,
Kepala Pelayanan Medis



Puput Sekar Nariratih, Amd.Keb, SE

Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes